



ПТСР: как это описывали советские врачи

09.05.2026 / Статьи



ВОЕННЫЙ НЕВРОЗ ИЛИ ПТСР: КАК ЭТО ОПИСЫВАЛИ СОВЕТСКИЕ ВРАЧИ

Автор: Жоров Е. Н.





военную психиатрию в отдельную дисциплину, а позднее связывал лечение военного невроза с особыми психотерапевтическими подходами. В исторических обзорах подчёркивается, что уже к первой половине XX века в отечественной медицине существовала своя линия понимания боевой психической травмы, в которой важное место занимали истощение, аффективные срывы, соматовегетативные расстройства и нарушения адаптации [2].

Во время Великой Отечественной войны этот подход стал частью практической медицины. По данным обзора Н. М. Жарикова, психиатрическая помощь в Красной армии постепенно перестраивалась так, чтобы быть ближе к фронту, а не сводиться к поздней эвакуации в тыл. При этом в структуре психических расстройств большое место занимали контузионные и травматические состояния. В цитируемых автором данных контузии составляли 69,4% случаев психических расстройств, требовавших специализированной психиатрической помощи [3].

В советской и более ранней русской военной медицине термин «контузия» понимался шире, чем в сегодняшнем бытовом языке. Речь шла прежде всего о поражении от взрывной или «воздушной» волны, которое могло сопровождаться потерей сознания, оглушением, вегетативными нарушениями, психическими симптомами и поздними неврологическими последствиями даже без явного проникающего ранения. Уже в литературе времён Первой мировой войны врачи спорили, вызывает ли «воздушная контузия» невроз или органическое поражение нервной системы, а в названиях работ тех лет рядом стояли «контузионный психоз», «психоневроз» и «травматический невроз» [5].

Сегодня есть соблазн автоматически перевести советское понимание термина «военный невроз» в современный диагноз ПТСР, но такая замена слишком груба. В отечественных историко-психиатрических работах прямо показано, что линия развития представлений шла от «синдрома раздражённого сердца» и чисто психогенных моделей к более сложному пониманию, включавшему органический компонент, последствия черепно-мозговой травмы, вегетативные нарушения и долговременные изменения личности и поведения [1].

Именно поэтому советские психиатры часто описывали боевую травму как состояние со множественными проявлениями. В одной клинической проблеме сходились страх, соматические жалобы, последствия контузии, депрессивные и



неожиданной потери близких [6].

Тем не менее исторические обзоры советской психиатрии военных лет показывают, что врачи-психиатры в то время были сфокусированны только на прагматических вопросах: как вернуть бойца в строй, как отличить обратимое состояние от более тяжёлого поражения, как организовать сортировку, лечение и реабилитацию. Поэтому советский язык описания был тесно связан с медицинской и военной задачей, но не с вопросами психиатрической классификации. Он хуже подходит для современных нозологических сопоставлений, зато хорошо передаёт сам опыт врачебного мышления той эпохи [3,4].

Почему это важно

Для современной психиатрии эта тема интересна по нескольким причинам. Во-первых, она напоминает, что ПТСР не возникло на пустом месте и что до него существовали богатые клинические описания боевой психической травмы. Во-вторых, советская традиция полезна как напоминание о том, что травматическое расстройство редко бывает «чисто психологическим». Боевой стресс почти всегда переплетён с истощением, телесной травмой, неврологическими симптомами, социальной дезадаптацией и изменениями личности.

Что это меняет

История военного невроза показывает, что старые клинические языки могут быть концептуально несовершенными, но при этом содержать наблюдения, которые не потеряли ценности. Советские врачи описывали боевую психическую травму менее формализованно, зато часто видели её как сложное пограничное состояние между психогенией, органикой и нарушенной адаптацией. В этом смысле разговор о военном неврозе сегодня интересен как способ лучше понять, сколько уровней реальности скрывается за современным диагнозом ПТСР.



[4] Фастовцов Г.А. Психиатрическая помощь военнослужащим Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 2020.

[5] Казакова О.Ю. Первая мировая война и развитие отечественной психиатрии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2016;116(3):68-72.

[6] В. А. Гиляровский «Психиатрия» <https://www.psychiatry.ru/lib/1/book/93>

Автор: Жоров Е. Н.

« Previous Post: Экология и социальная среда могут ускорять старение мозга сильнее, чем клинический диагноз

Next Post: Орексиновая система при острой мании »